



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
UPAYA MENGURANGI RISIKO CEDERA
PASIENT AKIBAT JATUH
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 633.14/I-PND/DIR/VII/2025

Tentang
Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh

Disusun oleh :



(Khusnul khotimah, S. Kep, Ns.)

Disetujui oleh :

Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 633.14/I-PND/DIR/VII/2025**

TENTANG

PANDUAN UPAYA MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur 633.14/I-PND/DIR/VII/2025 tentang Pedoman Upaya Keselamatan Pasien
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128 Tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PANDUAN UPAYA MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH**

Pasal 1

- (1) Rumah sakit melaksanakan skrining pasien rawat jalan pada kondisi, diagnosis, situasi atau lokasi yang dapat menyebabkan pasien berisiko jatuh, dengan menggunakan alat bantu/ metode skrining sesuai dengan regulasi

-
- (2) Skrining hanya meliputi pertanyaan dengan jawaban sederhana : ya/ tidak
 - (3) Tindakan dan/ atau intervensi dilakukan untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien jika hasil skrining menunjukkan adanya risiko jatuh
 - (4) Hasil skrining serta intervensi didokumentasikan

Pasal 2

- (1) Risiko jatuh pada pasien rawat jalan berhubungan dengan kondisi pasien, situasi, dan/ atau lokasi di rumah sakit
- (2) Hasil skrining pasien berisiko jatuh harus dilakukan intervensi lanjut

Pasal 3

- (1) Pengkajian risiko jatuh pada semua pasien rawat inap baik dewasa maupun anak dilakukan sesuai regulasi
- (2) Pengkajian ulang risiko jatuh pada pasien rawat inap dilakukan pada saat terjadi perubahan kondisi, atau memang sudah mempunyai risiko jatuh dari hasil pengkajian
- (3) Tindakan dan/ atau intervensi untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien rawat inap telah dilakukan dan didokumentasikan

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor 083/I-PER/DIR/I/2018 tentang Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 1 Juli 2025
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan KaruniaNya Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi upaya-upaya dalam mengurangi risiko jatuh, dan menghindari cedera akibat jatuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PANDUAN UPAYA MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH

PENGARAH

Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Pelaksana

1. dr. Nur Mazidah
2. Indah Maulhayati, S. Kep. Ns
3. Artika Wulandari, S. Kep. Ns
4. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep. Ns
5. Fadhila Ayu Setyani, S. Kep. Ns
6. Afni Nur Ainy, S. Kep. Ns
7. Khusnul Khotimah, S. Kep. Ns
8. Wiwit Indah Yanti, S. Kep. Ns
9. Very Susanto, S. Kep. Ns
10. Murwani Suryaning S, S. Kep, Ns
11. Sherly Rosita, S. Kep, Ns
12. Dan seluruh staf di RS Prima Husada Malang

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PENGESAHAN ii

PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA iii

KATA PENGANTAR iv

TIM PENYUSUN v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Sasaran 2

1.4. Ruang Lingkup 2

1.5. Pengertian 2

BAB II RUANG LINGKUP 3

2.1. Skrining Risiko Jatuh Gawat Darurat 3

2.2. Asesmen Risiko Jatuh Rawat Jalan 4

2.3. Asesmen Risiko Jatuh Pada Dewasa (*Morse Fall Scale*) 4

2.4. Asesmen Risiko Jatuh Pada Pediatrik 5

2.5. Asesmen Risiko Jatuh Pada Geriatri 8

BAB III TATA LAKSANA 11

3.1. Tata Laksana 11

Algoritma Penatalaksanaan Risiko Jatuh Pasien Masuk Rumah Sakit 14

BAB IV PENUTUP 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Algoritma Penatalaksanaan Risiko Jatuh Pasien Masuk Rumah Sakit14

DAFTAR TABEL

Table 2.1Tabel Jenis Asesmen3

Tabel 2.2 Asesmen Awal Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*).....5

Tabel 2.3 Asesmen Ulang Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*)5

Tabel 2.4 Tatalaksana Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*)5

Table 2.5 Asesmen Awal Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak)7

Table 2.6 Asesmen Ulang Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak).....8

Table 2.7 Tatalaksana Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak)8

Table 2.8 Asesmen Awal Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring*..... 10

Table 2.9 Asesmen Ulang Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring* 10

Table 2.10 Tatalaksana Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring*..... 11

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 633.14/I-PND/DIR/VII/2025
TENTANG
PANDUAN UPAYA MENGURANGI RISIKO
CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH

PANDUAN UPAYA MENGURANGI RISIKO CEDERA PASIEN AKIBAT JATUH

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Keselamatan pasien merupakan tanggung jawab seluruh petugas di rumah sakit. Dalam rangka menurunkan risiko cedera akibat jatuh pada pasien, petugas akan menilai dan melakukan penilaian ulang terhadap kategori risiko jatuh pasien, serta bekerjasama dalam memberikan intervensi pencegahan jatuh sesuai prosedur.

Banyak cedera yang terjadi di unit rawat inap dan rawat jalan akibat pasien jatuh. Berbagai faktor yang meningkatkan risiko pasien jatuh antara lain: kondisi pasien, diagnosis, situasi dan lokasi pasien.

Pasien yang pada asesmen awal dinyatakan berisiko rendah untuk jatuh dapat mendadak berubah menjadi berisiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh operasi dan/atau anestesi, perubahan mendadak kondisi pasien, serta penyesuaian pengobatan. Banyak pasien memerlukan asesmen selama dirawat inap di rumah sakit. Rumah sakit harus menetapkan kriteria untuk identifikasi pasien yang dianggap berisiko tinggi jatuh. Contoh situasional risiko adalah jika pasien yang datang ke unit rawat jalan dengan ambulans dari fasilitas rawat inap lainnya untuk pemeriksaan radiologi. Pasien ini berisiko jatuh waktu dipindah dari brankar ke meja periksa radiologi, atau waktu berubah posisi sewaktu berada di meja sempit tempat periksa radiologi.

Lokasi spesifik dapat menyebabkan risiko jatuh bertambah karena layanan yang diberikan. Misalnya, terapi fisik (rawat jalan dan rawat inap) memiliki banyak peralatan spesifik digunakan pasien yang dapat menambah risiko pasien jatuh seperti *parallel bars*, *freestanding staircases*, dan peralatan lain untuk latihan.

Rumah sakit melakukan evaluasi tentang pasien jatuh dan melakukan upaya mengurangi risiko pasien jatuh. Rumah sakit membuat program untuk mengurangi pasien jatuh yang meliputi manajemen risiko dan asesmen ulang secara berkala di populasi pasien dan atau lingkungan tempat pelayanan dan asuhan itu diberikan.

Rumah sakit harus bertanggung jawab untuk identifikasi lokasi (seperti unit terapi fisik), situasi (pasien datang dengan ambulans, transfer pasien dari kursi roda atau cart), tipe pasien, serta gangguan fungsional pasien yang mungkin berisiko tinggi untuk jatuh. Rumah sakit menjalankan program pengurangan risiko jatuh dengan menetapkan regulasi yang sesuai dengan lingkungan dan fasilitas rumah sakit. Program ini mencakup monitoring terhadap kesengajaan dan atau ke-dak-sengajaan dari kejadian jatuh. Misalnya, pembatasan gerak (*restrain*) atau *intake* pembatasan cairan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud disusunnya Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit pencegahan pasien cedera karena jatuh.
2. Tujuan
 - a. Mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko tinggi jatuh dengan menggunakan “Asesmen Risiko Jatuh”.
 - b. Melakukan asesmen ulang pada semua pasien (setiap hari)
 - c. Melakukan asesmen yang berkesinambungan terhadap pasien yang berisiko jatuh dengan menggunakan “Asesmen Risiko Jatuh Harian”
 - d. Menetapkan standar pencegahan dan penanganan risiko jatuh secara komprehensif

1.3. SASARAN

Sasaran Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh adalah semua yang ada di Rumah Sakit Prima Husada guna tercapainya keselamatan pasien.

1.4. PENGERTIAN

Jatuh adalah suatu peristiwa di mana seseorang mengalami jatuh dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain, tidak disengaja/ tidak direncanakan, dengan arah jatuh ke lantai, dengan atau tanpa mencederai dirinya. Penyebab jatuh dapat meliputi faktor fisiologis (pingsan) atau lingkungan (lantai yang licin).

Risiko jatuh adalah pasien yang berisiko untuk jatuh yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor fisiologis yang dapat berakibat cedera. Faktor risiko jatuh dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori:

1. Intrinsik: berhubungan dengan kondisi pasien, termasuk kondisi psikologis
2. Ekstrinsik: berhubungan dengan lingkungan

Selain itu, faktor risiko juga dapat dikelompokkan menjadi kategori dapat diperkirakan (*anticipated*) dan tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*). Faktor risiko yang dapat diperkirakan merupakan hal-hal yang diperkirakan dapat terjadi sebelum pasien jatuh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh meliputi: Rawat Jalan, Rawat Inap, Unit Darurat, Kamar Operasi, ICU, Unit Layanan Diagnostik, dan lainnya. Pelaksana panduan ini adalah para tenaga kesehatan (medis, perawat, farmasi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya); staf di ruang rawat, staf administratif, dan staf pendukung yang bekerja di rumah sakit.

Skrining pada umumnya berupa evaluasi sederhana meliputi pertanyaan dengan jawaban sederhana : ya/ tidak, atau metode lain meliputi pemberian nilai/ skor untuk setiap respon pasien. Skrining dapat dilakukan oleh petugas registrasi, atau pasien dapat melakukan skrining secara mandiri, seperti di kunjungan mandiri untuk skrining pasien di unit rawat jalan.

Asesmen lebih mendalam dibutuhkan untuk identifikasi pasien yang memerlukan intervensi lanjutan. Ini berlaku untuk semua pasien rawat inap dewasa baik anak harus dilakukan pengkajian lanjutan terkait risiko jatuh. Penggunaan metode pengkajian ini merupakan bentuk baku, dan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.

Pasien yang sebelumnya risiko rendah jatuh dapat meningkat risikonya secara mendadak menjadi risiko tinggi jatuh. Perubahan ini dapat diakibatkan, namun tidak terbatas pada tindakan pembedahan dan/ atau anastesi, perubahan mendadak pada kondisi pasien, dan penyesuaian obat-obatan yang diberikan sehingga pasien memerlukan pengkajian ulang jatuh selama dirawat inap dan paska pembedahan.

Table 2.1 Tabel Jenis Asesmen

Keterangan	Intrinsik (berhubungan dengan kondisi pasien)	Ekstrinsik (berhubungan dengan lingkungan)
Dapat diperkirakan	a. Riwayat jatuh sebelumnya b. Inkontinensia c. Dizziness d. Gangguan penglihatan e. Penggunaan obat/ sedasi f. Konsumsi alkohol g. Gangguan kognitif/psikologis h. Gangguan keseimbangan/mobilitas i. Usia > 65 tahun j. Osteoporosis k. Status kesehatan yang buruk l. Gangguan muskuloskeletal	a. Lantai basah/ silau, ruang berantakan, pencahayaan kurang, kabel longgar/lepas b. Alas kaki tidak pas c. Dudukan toilet yang rendah d. Kursi atau tempat tidur beroda e. Rawat inap berkepanjangan f. Peralatan yang tidak aman g. Peralatan rusak h. Tempat tidur ditinggalkan posisi tinggi
Tidak dapat diperkirakan	a. Kejang b. Aritmia jantung c. Stroke atau TIA d. Pingsan e. 'Serangan jatuh' (<i>Drop Attack</i>) f. Penyakit kronis	Reaksi individu terhadap obat- obatan

2.1. Skrining Risiko Jatuh Gawat Darurat

Skrining dilakukan di IGD dengan cepat dan tepat, berikut skrining yang dilakukan di rumah sakit dengan menjawab 3 pertanyaan:

1. Apakah pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?

2. Apakah menggunakan alat bantu?
3. Apakah ada kesulitan berjalan?

Kemudian dilakukan asuhan skrining kebutuhan fungsional dan risiko jatuh:

1. Pemasangan stiker kuning penanda risiko jatuh di gelang identitas pasien
2. Pemasangan tanda risiko jatuh pada bed pasien
3. Pendampingan keluarga

Dan dilakukan asesmen lanjutan risiko jatuh rawat inap sesuai dengan tools yang digunakan

2.2. Skrining Risiko Jatuh Rawat Jalan

Pada skrining jatuh di rawat jalan, pelaku skrining adalah bagian pendaftaran pasien, yaitu dengan menggunakan 3 pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?
2. Apakah menggunakan alat bantu?
3. Apakah ada kesulitan berjalan?

Saat melakukan skrining, jika ada salah 1 jawaban “Ya” dari 3 pertanyaan tersebut, maka pasien diberikan tanda pita kuning pada lengan pasien. Dan tanda stiker risiko jatuh pada alat bantu pasien (kursi roda dan/ dragbar).

2.3. Asesmen Awal dan Ulang Risiko Jatuh Pada Dewasa (*Morse Fall Scale*)

1. Diagnosis Sekunder (≥ 2 Diagnosis Medis)
Jika pasien memiliki lebih dari satu diagnosis medis, berikan skor 15; jika tidak, berikan skor 0
2. Gaya Berjalan (Ambulasi)
 - a. Jika pasien mengalami gangguan gaya berjalan; mengalami kesulitan untuk bangun dari kursi, menggunakan bantalan tangan kursi untuk mendorong tubuhnya, kepala menunduk, pandangan mata terfokus pada lantai, memerlukan bantuan sedang – total untuk menjaga keseimbangan dengan berpegangan pada perabot, orang, atau alat bantu berjalan, dan langkah-langkahnya pendek; berikan skor 20.
 - b. Jika pasien memiliki gaya berjalan yang lemah; pasien membungkuk; tidak dapat mengangkat kepala tanpa kehilangan keseimbangan, atau memerlukan bantuan ringan untuk berjalan; dan langkah-langkahnya pendek; berikan skor 10.
 - c. Jika pasien memiliki gaya berjalan normal, berikan skor 0
3. Kondisi Mental
Identifikasi asesmen pasien terhadap dirinya sendiri mengenai kemampuannya untuk berjalan. Jika pasien mempunyai over-estimasi terhadap kemampuan fisiknya, berikan skor 15. Jika asesmen pasien sesuai dengan kemampuan sebenarnya, berikan skor 0.
4. Alat Bantu (Tongkat)
Jika pasien berpegangan pada perabot untuk berjalan, berikan skor 30. Jika pasien menggunakan tongkat / alat penopang, berikan skor 15. Jika pasien dapat berjalan tanpa alat bantu, berikan skor 0.
5. Terpasang Infus
Jika pasien terpasang infus, berikan skor 20; jika tidak, berikan skor 0.
6. Riwayat Jatuh
Jika pasien mengalami kejadian jatuh saat masuk rumah sakit atau terdapat riwayat kejadian jatuh fisiologis dalam 12 bulan terakhir ini, seperti pingsan atau gangguan gaya berjalan, berikan skor 25. Jika pasien tidak mengalami jatuh, berikan skor 0.

Tabel 2.2 Asesmen Awal Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*)

Pemeriksaan Risiko Jatuh (Dewasa)			
Faktor Risiko	Skala	Skor	Kajian Awal
Diagnosis Sekunder (≥2 Diagnosis Medis)	Ya	15	
	Tidak	0	
Gaya Berjalan (Ambulasi)	Terganggu / Tidak Normal/ Pincang/ Diseret	20	
	Lemah/ Tidak Bertenaga	10	
	Normal/ Tidak Dapat Bergerak Sendiri / Bedrest (tirah baring)	0	
Kondisi Mental	Tidak Menyadari Atas Keterbatasan Yand Dimiliki	15	
	Sadar Akan Kemampuan Diri Sendiri	0	
Alat Bantu (Tongkat)	Berjalan dengan berpegangan pada furniture	30	
	Berjalan dengan penopang (tongkat, kursi roda, manusia)	15	
	Berjalan normal/ Tidak menggunakan alat bantu	0	
Terpasang Infus	Ya	20	
	Tidak	0	
Riwayat Jatuh	Ya	25	
	Tidak	0	
Total Skor			
Skala : 0 - 24 = Rendah, 25 - 44 = Sedang, ≥ 45 = Tinggi			

Tabel 2.3 Asesmen Ulang Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*)

Faktor Risiko	Skala	Skor	Kajian Awal	Kajian Ulang					
				Tanggal					
Diagnosis Sekunder (≥2 Diagnosis Medis)	Ya	15							
	Tidak	0							
Gaya Berjalan (Ambulasi)	Terganggu / Tidak Normal/ Pincang/ Diseret	20							
	Lemah/ Tidak Bertenaga	10							
	Normal/ Tidak Dapat Bergerak Sendiri / Bedrest (tirah baring)	0							
Kondisi Mental	Tidak Menyadari Atas Keterbatasan Yang Dimiliki	15							
	Sadar Akan Kemampuan Diri Sendiri	0							
Alat Bantu (Tongkat)	Berjalan dengan berpegangan pada furniture	30							
	Berjalan dengan penopang (tongkat, kursi roda, manusia)	15							
	Berjalan normal/ Tidak menggunakan alat bantu	0							
Terpasang Infus	Ya	20							
	Tidak	0							
Riwayat Jatuh	Ya	25							
	Tidak	0							
Total Skor									
Kesimpulan									
Nama Dan Paraf Yang Melakukan Penilaian									
Keterangan :									
Skala : 0 – 24 = Rendah , 25 – 44 = Sedang, ≥ 45 = Tinggi									

Tabel 2.4 Tatalaksana Risiko Jatuh Dewasa (*Morse False Scale*)

INTERPRETASI	LANGKAH-LANGKAH INTERVENSI
0-24 Risiko Rendah	1. Lakukan orientasi lingkungan dan kegiatan rutin rumah sakit : letak kamar mandi, nurse station, stop kontak, bel pasien, dll 2. Lakukan kolaborasi multi disiplin dalam perencanaan perawatan risiko jatuh

	3. Lakukan edukasi pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarga 4. Pastikan ruangan dan kamar mandi selalu rapi dan kering 5. Tempatkan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien 6. Pastikan alat bantu dengar atau kacamata ada di dekat pasien dan berfungsi (bagi yang menggunakan alat tersebut) 7. Posisikan tempat tidur pasien berada dalam posisi rendah dengan rem dan handrail dalam posisi terkunci 8. Pastikan jalan ke kamar mandi bebas hambatan dan terang 9. Pertimbangkan menempatkan dekat kamar mandi bagi pasien yang sering ke kamar mandi 10. Letakkan alat bantu mobilisasi dekat dengan pasien (tongkat, walker, tripod, dll) 11. Diskusikan status risiko jatuh pasien pada setiap pergantian shift 12. Lakukan pengawasan pada pasien yang menggunakan obat yang menimbulkan risiko jatuh 13. Lakukan evaluasi pada status mental pasien 14. Gunakan sandal anti slip 15. Bantu pasien ke WC/ penggunaan pisipot
25-44 Risiko Sedang	Semua hal yang diatas, ditambah : 1. Sediakan urinier dekat pasien 2. Konsultasikan fisioterapi jika perlu 3. Pasang stiker kuning pada gelang pasien 4. Pasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur pasien
≥ 45 Risiko Tinggi	Semua hal yang diatas, ditambah : 1. Letakkan tempat tidur pasien dekat dengan nurse station 2. Libatkan keluarga dalam monitoring 3. Kunjungi dan monitor pasien setiap jam 4. Jangan tinggalkan pasien tanpa pengawasan di kamar mandi atau mobilisasi

2.4. Asesmen Awal dan Ulang Risiko Jatuh Pada Pediatrik

Asesmen risiko jatuh merupakan suatu alat yang dapat mengidentifikasi secara cepat mengenai faktor risiko jatuh yang dimiliki pasien sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan, proteksi, dan pemantauan pasien selama dirawat. Asesmen risiko jatuh ini termasuk dalam komponen program pencegahan jatuh yang komprehensif.

Terdapat 4 hal yang diperkirakan berperan serta terhadap risiko jatuh pada pediatrik, yaitu:

1. Lingkungan serta penggunaan peralatan di rumah sakit yang baru (tidak familiar) terhadap pasien pediatric
2. Pasien pediatri yang dirawat biasanya berkaitan dengan gangguan kemampuan motorik dan kognitif pasien
3. Tahapan perkembangan kemampuan motorik dan kognitif pasien mempengaruhi risiko jatuh. Anak-anak yang berisiko tinggi jatuh adalah:
 - a. Anak pre-sekolah
 - b. Usia < 10 tahun memiliki risiko jatuh 2 kali lipat lebih tinggi dalam populasi total
 - c. Anak dengan disabilitas dan keterbatasan gerak (mobilitas)
 - d. Anak yang menggunakan kursi roda, tanpa melihat kemampuan kognitifnya.

Asesmen Risiko Jatuh untuk Pediatrik: Humpty Dumpty Fall Prevention dinilai sebagai alat asesmen risiko jatuh yang valid dan telah diterapkan oleh berbagai rumah sakit di seluruh dunia.

Asesmen Risiko Jatuh Pediatrik ‘Humpty Dumpty’, terdiri dari 7 kategori:

- 1. Jenis kelamin (sex)
- 2. Gangguan kognitif
- 3. Penggunaan obat
- 4. Pengaruh dari operasi/ obat penenang/ anastesi
- 5. Diagnose
- 6. Umur
- 7. Factor lingkungan

Table 2.5 Asesmen Awal Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak)

Pemeriksaan Risiko Jatuh (Pediatri)			
Faktor Risiko	Skala	Skor	Kajian Awal
Jenis Kelamin (Sex)	Laki-laki	2	
	Perempuan	1	
Gangguan Kognitif	Tidak menyadari atas keterbatasan	3	
	Lupa keterbatasan	2	
	Mengetahui kemampuan diri	1	
Penggunaan Obat	Bermacam-macam obat yang digunakan : obat sedatif (kecuali pasien ICU yang menggunakan sedasi dan paralisis), Hipnotik, Barbiturat, Fenotiazin, Anti Depressn, Laksans/ Diuretik, Narkotik	3	
	Salah satu dari pengobatan di atas	2	
	Pengobatan lain	1	
Pengaruh dari operasi / obat penenang / Anastesi	Dalam 24 jam	3	
	Dalam 48 jam	2	
	>48 jam	1	
	Tidak ada tindakan operasi/ tidak mendapat obat penenang/ anastesi	0	
Diagnosa	Kelainan neurologis (sinkop/ sakit kepala)	4	
	Perubahan dalam oksigenasi (masalah saluran nafas & pernafasan, dehidrasi, anemia, anoreksia, dll)	3	
	Kelainan Psikis / Perilaku	2	
	Diagnosa lain	1	
Umur	Dibawah 3 th	4	
	3-7 th	3	
	7-13 th	2	
	>13 th	1	
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh dari tempat tidur	4	
	Pasien menggunakan alat bantu jalan / baby walker / mebel	3	
	Pasien berada di tempat tidur	2	
	Diluar ruang rawat (pasien aktif mobilisasi)	1	
Total Skor			
Skala : 7-11 : Risiko Rendah >12 : Risiko Tinggi			

Table 2.6 Asesmen Ulang Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak)

ANAK (HUMPTY DUMPTY)									
Faktor Risiko	Skala	Skor	Kajian Awal	Kajian Ulang					
				Tanggal					
Jenis Kelamin (Sex)	Laki-laki	2							
	Perempuan	1							
Gangguan Kognitif	Tidak menyadari atas keterbatasan	3							
	Lupa keterbatasan	2							
	Mengalami kemampuan diri	1							
Penggunaan Obat	Bermacam-macam obat yang digunakan : obat sedatif (kecuali pasien ICU yang menggunakan sedasi dan paralisis), Hipnotik, Barbiturat, Fenotiazin, Anti Depresan, Laksans/ Diuretik, Narkotik	3							
	Salah satu dari pengobatan di atas	2							
	Pengobatan lain	1							
Pengaruh dari operasi/ obat penenang/ Anastesi	Dalam 24 jam	3							
	Dalam 48 jam	2							
	>48 jam	1							
	Tidak ada tindakan operasi/ tidak mendapat obat penenang/ anastesi	0							
Diagnosa	Kelainan neurologis (sinkop/ sakit kepala)	4							
	Perubahan dalam oksigenasi (masalah saluran nafas & pernafasan, dehidrasi, anemia, anoreksia, dll)	3							
	Kelainan Psikis/ Perilaku	2							
	Diagnosa lain	1							
Umur	Dibawah 3 th	4							
	3-7 th	3							
	7-13 th	2							
	>13 th	1							
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh dari tempat tidur	4							
	Pasien menggunakan alat bantu jalan/ baby walker/ mebel	3							
	Pasien berada di tempat tidur	2							
	Diluar ruang rawat (pasien aktif mobilisasi)	1							
Total Skor									
Kesimpulan									
Nama dan Paraf yang melakukan penilaian									
Keterangan : Skala : 7-11 : Risiko Rendah >12 : Risiko Tinggi									

Table 2.7 Tatalaksana Risiko Jatuh *Humpty Dumpty Scale* (pada anak)

INTERPRETASI	LANGKAH-LANGKAH INTERVENSI
7-11 Risiko Rendah	1. Nilai kebutuhan pasien, berikan bantuan jika dibutuhkan 2. Tombol pemanggil staf terletak dalam jangkauan pasien, berikan edukasi kepada pasien / keluarga mengenai fungsi tombol ini 3. Bebaskan lingkungan perawatan dari peralatan yang tidak perlu, perabot terletak pada tempatnya, ruangan bebas potensi bahaya (misalnya: kabel yang tercecer di lantai, licin) 4. Orientasi terhadap ruang rawat 5. Posisi tempat tidur rendah, disesuaikan dengan tinggi pasien,rem tempat tidur berfungsi baik 6. <i>Side rails</i> terpasang dengan baik, nilai apakah terdapat celah yang lebar di samping tempat tidur agar bagian tubuh pasien tidak tersangkut, gunakan metode / prosedur proteksi tambahan 7. Gunakan alas kaki anti-licin untuk mobilisasi pasien 8. Gunakan ukuran pakaian yang pas dengan tubuh pasien untuk mencegah risiko terjerebab 9. Penggunaan cahaya yang adekuat, berikan lampu tidur di malam hari 10. Berikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisipasien 11. Masukkan program pencegahan jatuh dalam rencana perawatan 12. Pasien & catat di rekam medis
>12 Risiko Tinggi	1. Identifikasi pasien dengan label / stiker ‘Humpty Dumpty’ seperti di bawah ini. Tempelkan pada pasien, tempat tidur, dan kartu perawatan pasien. 2. Periksa / lakukan pengecekan pada pasien minimal setiap jam

	3. Temani pasien yang sedang melakukan mobilisasi 4. Tempatkan ruangan pasien dekat dengan pos perawat 5. Nilai kebutuhan pasien dan lakukan pengawasan 1 : 1 6. Evaluasi waktu pemberian medikamentosa 7. Jangan menempatkan peralatan yang tidak diperlukan di dalam ruangan 8. Gunakan proteksi pada tempat-tempat yang berpotensi meningkatkan risiko jatuh pasien, misalnya: celah di samping tempat tidur. 9. Pastikan pintu selalu terbuka setiap waktu kecuali diperlukan tindakan isolasi 10. Pastikan tempat tidur berada dalam posisi terendah, kec pasien diawasi langsung oleh orang lain 11. Berikan edukasi kepada pasien / keluarga mengenai pencegahan jatuh 12. Catatlah di dalam rekam medis pasien
--	--

2.5. Asesmen Awal dan Ulang Risiko Jatuh Pada Geriatri

Skrining Risiko jatuh :

1. Merupakan suatu alat untuk memperkirakan risiko jatuh yang dimiliki seseorang.
2. Klasifikasi: risiko rendah, terdapat peningkatan risiko jatuh
3. Semua pasien geriatri yang dirawat di rumah sakit harus menjalani skrining risiko atuh, dan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin
4. Skrining ini juga dilakukan pada pasien yang mengalami perubahan kondisi / status kesehatan / fungsionalnya.
5. Alat skrining yang telah diakui dan sering digunakan di banyak rumah sakit adalah Ontario Modified STRATIFY (Sydney Scoring). Alat skrining ini merupakan modifikasi dari Sir Thomas Risk Assessment Tool in Falling Elderly In-patients (STRATIFY). Berikut ini disajikan tabel mengenai Sydney Scoring.

Table 2.8 Asesmen Awal Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring*

PENGKAJIAN RISIKO JATUH PASIEN GERIATRI					
No	Parameter	Skrining	Jawab	Keterangan Nilai	Kajian Awal
1	Riwayat Jatuh	Apakah Pasien Datang Ke Rumah Sakit Karena Jatuh?	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 6	
		Jika Tidak, Apakah Pasien Mengalami Jatuh Dalam 2 Bulan Terakhir Ini?	Ya / Tidak		
2	Status Mental	Apakah Pasien Delirium? (Tidak Dapat Membuat Keputusan, Pola Pikir Tidak Terorganisir, Gangguan Daya Ingat)	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 14	
		Apakah Pasien Disorientasi? (Salah Menyebutkan Waktu, Tempat, Atau Orang)	Ya / Tidak		
		Apakah Pasien Mengalami Agitasi? (Ketakutan, Gelisah, Dan Cemas)	Ya / Tidak		
3	Penglihatan	Apakah Pasien Memakai Kacamata?	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 1	
		Apakah Pasien Mengeluh Adanya Penglihatan Buram?	Ya / Tidak		
		Apakah Pasien Mempunyai Glaukoma, Katarak, Atau Degenerasi Makula?	Ya / Tidak		
4	Kebiasaan Berkemih	Apakah Terdapat Perubahan Perilaku Berkemih? (Frekuensi, Urgensi, Inkontinensia, Nokturia)	Ya / Tidak	Ya = 2	
5	Transfer (Dari Tempat Tidur Ke Kursi Dan Kembali Ke Tempat Tidur)	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0	Jumlahkan Nilai Transfer Dan Mobilitas. Jika Nilai Total 0-3, Skor = 0.	
		Memerlukan Sedikit Bantuan (1 Orang) / Dalam Pengawasan	1		
		Memerlukan Bantuan Yang Nyata (2 Orang)	2		
		Tidak Dapat Duduk Dengan Seimbang, Perlu Bantuan Total	3		
6	Mobilitas	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0	Jika Nilai Total 4-6, Skor = 7	
		Berjalan Dg Bantuan 1 Orang (Verbal / Fisik)	1		
		Menggunakan Kursi Roda	2		
		Imobilisasi	3		
Total Skor					

Table 2.9 Asesmen Ulang Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring*

ONTARIO MODIFIED STRATIFY - SYDNEY SCORING

No	Parameter	Skrining	Jawab	Keterangan Nilai	Kajian Awal	Kajian Ulang					
						Tanggal					
1	Riwayat Jatuh	Apakah Pasien Datang Ke Rumah Sakit Karena Jatuh?	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 6							
		Jika Tidak, Apakah Pasien Mengalami Jatuh Dalam 2 Bulan Terakhir Ini?	Ya / Tidak								
2	Status Mental	Apakah Pasien Delirium? (Tidak Dapat Membuat Keputusan, Pola Pikir Tidak Terorganisir, Gangguan Daya Ingat)	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 14							
		Apakah Pasien Disorientasi? (Salah Menyebutkan Waktu, Tempat, Atau Orang)	Ya / Tidak								
		Apakah Pasien Mengalami Agitasi? (Ketakutan, Gelisah, Dan Cemas)	Ya / Tidak								
3	Penglihatan	Apakah Pasien Memakai Kacamata?	Ya / Tidak	Salah Satu Jawaban Ya = 1							
		Apakah Pasien Mengeluh Adanya Penglihatan Buram?	Ya / Tidak								
		Apakah Pasien Mempunyai Glaukoma, Katarak, Atau Degenerasi Makula?	Ya / Tidak								
4	Kebiasaan Berkemih	Apakah Terdapat Perubahan Perilaku Berkemih? (Frekuensi, Urgensi, Inkontinensia, Nokturia)	Ya / Tidak	Ya = 2							
5	Transfer (Dari Tempat Tidur Ke Kursi Dan Kembali Ke Tempat Tidur)	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0	Jumlahkan Nilai Transfer Dan Mobilitas. Jika Nilai Total 0-3, Skor = 0. Jika Nilai Total 4-6, Skor = 7							
		Memerlukan Sedikit Bantuan (1 Orang) / Dalam Pengawasan	1								
		Memerlukan Bantuan Yang Nyata (2 Orang)	2								
		Tidak Dapat Duduk Dengan Seimbang, Perlu Bantuan Total	3								
6	Mobilitas	Mandiri (Boleh Menggunakan Alat Bantu Jalan)	0								
		Berjalan Dg Bantuan 1 Orang (Verbal / Fisik)	1								
		Menggunakan Kursi Roda	2								
		Imobilisasi	3								
Total Skor											

Table 2.10 Tatalaksana Risiko Jatuh *Ontario Modified Stratify - Sydney Scoring*

Daftar Obat-obatan (tandai obat-obatan yang dikonsumsi pasien):			
Satu atau lebih penggunaan obat-obatan di bawah ini dapat meningkatkan risiko jatuh:			
☐ Antihipertensi	☐ Benzodiazepine	☐ Antiparkinson	☐ Opioid
☐ Hipoglikemia	☐ Antikonvulsan	☐ Pencabar	☐ Psikotropika
☐ Diuretic			

INTERPRETASI	LANGKAH-LANGKAH INTERVENSI
0-5 Risiko Rendah	1. Orientasi kamar tidur dan lingkungan rawat inap, beserta staf rumah sakit 2. Posisikan tempat tidur pasien rendah. Pastikan rem tempat tidur berfungsi dengan baik 3. Alarm, tombol pemanggil, dan meja samping dapat dijangkau tangan pasien, intruksikan pasien untuk memanggil bantuan jika memerlukan sesuatu 4. Pastikan penggunaan alas kaki yang aman saat mobilisasi 5. Sediakan brosur pemakaian alas kaki yang aman kepada pasien dan keluarga 6. Pakaian pasien berukuran pas (tidak terlalu besar / kecil) 7. Amankan area dari perabot yang tidak stabil, ruangan yang berantakan 8. Sediakan brosur pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarga 9. Pastikan pasien memperoleh nutrisi dan hidrasi yang adekuat 10. Peninjauan obat-obatan 11. Obat-obatan untuk proteksi tulang: pertimbangkan suplementasi vitamin d dan kalsium 12. Pastikan pasien memakai kacamata dan alat bantu dengar (jika diperlukan)
6-16 Risiko Sedang	Semua hal yang diatas, ditambah : 1. Gunakan tanda pengenal untuk 'risiko jatuh' 2. Awasi pasien saat mobilisasi 3. Awasi pasien saat menggunakan kamar mandi 4. Pantau nutrisi dan hidrasi pasien 5. Gunakan karpet anti-licin di dekat tempat tidur 6. Rujuk ke fisioterapi dan atau okupasional terapi untuk asesmen lebih lanjut
17-30 Risiko Tinggi	Semua hal yang diatas, ditambah : 1. Jangan tinggalkan pasien tanpa pengawasan saat di kamar mandi atau mobilisasi 2. Tempatkan kamar tidur pasien dekat dengan pos perawat 3. Pastikan tinggi tempat tidur sesuai dengan kebutuhan pasien 4. Pertimbangkan observasi konstan - terutama jika pasien delirium 5. Pertimbangkan penunaan protektor panggul

BAB III TATA LAKSANA

3.1. Tata Laksana

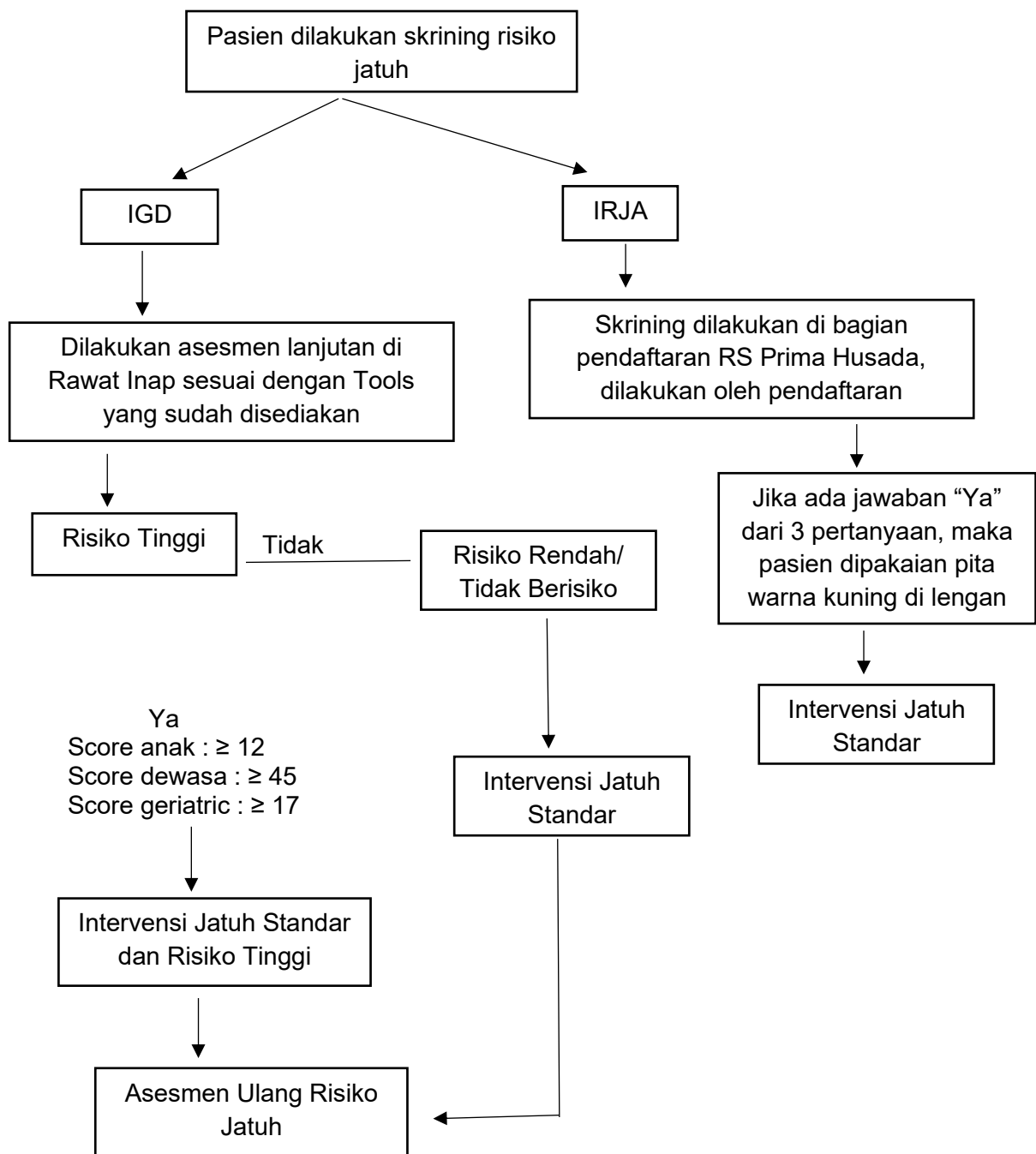
1. Petugas penanggung jawab: Perawat penanggung jawab pelayanan (PPJP)
2. Perangkat kerja
 - a. Status Rekam Medis Pasien
 - b. Tanda risiko pasien jatuh (stiker warna kuning dan penanda warna kuning di bed pasien)
 - c. Formulir pengkajian risiko pasien jatuh
 - d. Formulir dokumentasi informasi risiko pasien jatuh
 - e. Formulir catatan kegiatan perawat tentang asesmen dan intervensi risiko jatuh
3. Tatalaksana
 - a. Perawat IGD akan melakukan skrining risiko jatuh dengan tools yang sudah disediakan, juga menyangkut kebutuhan fungsional pasien
 - b. Selanjutnya akan dilakukan asesmen awal pada pasien rawat inap
 - 1) Perawat akan melakukan penilaian dengan Asesmen Risiko Jatuh Morse Fall Scale dan atau tool yang lainnya sesuai dengan usia pasien dalam waktu 4 jam dari pasien masuk RS dan mencatat hasil asesmen ke dalam dokumen rekam medis pasien
 - 2) Rencana intervensi akan segera disusun, diimplementasikan, dan dicatat dalam Rencana Keperawatan Interdisiplin dalam waktu 2 jam setelah skrining.
 - c. Asesmen ulang
 - 1) Setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang risiko jatuh setiap: dua kali saat transfer ke unit lain, adanya perubahan kondisi pasien, adanya kejadian jatuh pada pasien. Dan pada setiap skor pasien sedang, maka dilakukan asesmen ulang setiap hari.
 - 2) Penilaian menggunakan Asesmen Risiko Jatuh *Morse Fall Scale* dan Rencana Keperawatan Interdisiplin akan diperbaharui/dimodifikasi sesuai dengan hasil asesmen
 - 3) Untuk mengubah kategori dari risiko tinggi ke risiko rendah, diperlukan skor < 25 dalam 2 kali pemeriksaan berturut-turut.
 - d. Perawat penanggung jawab pelayanan yang bertugas akan mengidentifikasi dan menerapkan “Prosedur Pencegahan Jatuh”, berdasarkan pada:
 - 1) Kategori risiko jatuh (rendah, sedang, tinggi)
 - 2) Kebutuhan dan keterbatasan per-pasien
 - 3) Riwayat jatuh sebelumnya dan penggunaan alat pengaman (safety devices)
 - 4) Asesmen Klinis Harian
 - e. “Prosedur Pencegahan Jatuh” pada pasien yang berisiko rendah, sedang, atau tinggi harus diimplementasikan dan penggunaan peralatan yang sesuai harus optimal.
 - f. Intervensi pencegahan jatuh
 - 1) Tindakan pencegahan umum (untuk semua kategori):
 - a) Lakukan orientasi kamar inap kepada pasien
 - b) Posisikan tempat tidur serendah mungkin, roda terkunci, kedua sisi pegangan tempat tidur terpasang dengan baik
 - c) Ruang rapi
 - d) Benda-benda pribadi berada dalam jangkauan (telepon genggam, tombol panggilan, air minum, kacamata)
 - e) Pencahayaan yang adekuat (d disesuaikan dgn kebutuhan pasien)
 - f) Alat bantu berada dalam jangkauan (tongkat, alat penopang)
 - g) Optimalisasi penggunaan kacamata dan alat bantu dengar (pastikan bersih dan berfungsi)
 - h) Pantau efek obat-obatan
 - i) Anjuran ke kamar mandi secara rutin
 - j) Sediakan dukungan emosional dan psikologis

- k) Beri edukasi mengenai pencegahan jatuh pada pasien dan keluarga
 - 2) Kategori risiko tinggi: lakukan tindakan pencegahan umum dan hal-hal berikut ini.
 - a) Beri tulisan di dekat tempat tidur pasien 'Pencegahan Jatuh'
 - b) Beri penanda berupa stiker berwarna kuning yang dipakaikan di pergelangan tangan pasien
 - c) Sandal anti-licin
 - d) Tawarkan bantuan ke kamar mandi / penggunaan pispot setiap 2 jam (saat pasien bangun), dan secara periodik (saat malam hari)
 - e) Kunjungi dan amati pasien setiap 2 jam oleh petugas medis
 - f) Nilai kebutuhan akan:
 - Fisioterapi dan terapi okupasi
 - Alarm tempat tidur
 - Tempat tidur rendah (khusus)
 - Usahakan lokasi kamar tidur berdekatan dengan pos perawat (nurse station)
4. Strategi Rencana Keperawatan
 - a. Strategi umum untuk pasien risiko jatuh, yaitu:
 - 1) Tawarkan bantuan ke kamar mandi setiap 2 jam (saat pasien bangun)
 - 2) Gunakan 2-3 sisi pegangan tempat tidur
 - 3) Lampu panggilan berada dalam jangkauan, perintahkan pasien untuk mendemonstrasikan penggunaan lampu panggilan
 - 4) Jangan ragu untuk meminta bantuan
 - 5) Barang-barang pribadi berada dalam jangkauan
 - 6) Adakan konferensi multidisiplin mingguan dengan partisipasi tim keperawatan
 - 7) Rujuk ke departemen yang sesuai untuk asesmen yang lebih spesifik, misalnya fisioterapi
 - 8) Anjurkan pasien menggunakan sisi tubuh yang lebih kuat saat hendak turun dari tempat tidur
 - b. Strategi untuk mengurangi / mengantisipasi kejadian jatuh fisiologis, yaitu:
 - 1) Berikan orientasi kamar tidur kepada pasien
 - 2) Libatkan pasien dalam pemilihan aktivitas sehari-harinya
 - 3) Pantau ketat efek obat-obatan, termasuk obat psikotropika
 - 4) Kurangi suara berisik
 - 5) Lakukan asesmen ulang
 - 6) Sediakan dukungan emosional dan psikologis
 - c. Strategi pada faktor lingkungan untuk mengurangi risiko jatuh, yaitu:
 - 1) Lampu panggilan berada dalam jangkauan
 - 2) Posisi tempat tidur rendah
 - 3) Lantai tidak silau/memantul dan tidak licin
 - 4) Pencahayaan yang adekuat
 - 5) Ruangan rapi
 - 6) Sarana toilet dekat dengan pasien
 - 7) Meletakkan alat-alat pribadi pasien di dekat pasien
5. Manajemen Setelah Kejadian Jatuh
 - a. Nilai apakah terdapat cedera akibat jatuh (abrasi, kontusio, laserasi, fraktur, cedera kepala)
 - b. Nilai tanda vital
 - c. Nilai adanya keterbatasan gerak
 - d. Pantau pasien dengan ketat
 - e. Catat dalam status pasien (rekam medik)
 - f. Laporkan kejadian jatuh kepada perawat yang bertugas dan lengkapi laporan insidens
 - g. Modifikasi rencana keperawatan interdisiplin sesuai dengan kondisi pasien
6. Edukasi Pasien/ Keluarga

Pasien dan keluarga harus diinformasikan mengenai faktor risiko jatuh dan setuju untuk mengikuti strategi pencegahan jatuh yang telah ditetapkan. Pasien dan keluarga harus diberikan edukasi mengenai faktor risiko jatuh di lingkungan rumah sakit dan melanjutkan keikutsertaannya sepanjang keperawatan pasien.

-
- a. Informasikan pasien dan keluarga dalam semua aktivitas sebelum memulai penggunaan alat bantu
 - b. Ajari pasien untuk menggunakan pegangan dinding
 - c. Informasikan pasien mengenai dosis dan frekuensi konsumsi obat-obatan, efek samping, serta interaksinya dengan makanan/ obat-obatan lain.
 7. Dokumentasikan Semua Kegiatan Pencegahan Risiko Jatuh Pada Catatan Keperawatan
 - a. Dokumen assesmen risiko pasien jatuh
 - b. Dokumen pemberian informasi risiko pasien jatuh
 - c. Dokumen catatan keperawatan

Algoritma Penatalaksanaan Pasien Risiko Jatuh



Gambar 3.1 Algoritma Penatalaksanaan Risiko Jatuh Pasien Masuk Rumah Sakit

BAB IV PENUTUP

Sasaran Keselamatan Pasien yang wajib diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Rumah Sakit berperan penting dalam proses mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Rumah Sakit melaksanakan skrining pada pasien rawat jalan pada kondisi, diagnosis, situasi atau lokasi yang dapat menyebabkan pasien berisiko jatuh, dengan menggunakan alat bantu/ metode skrining.

Tindakan dan/ atau intervensi dilakukan untuk mengurangi risiko jatuh pada pasien jika hasil skring menunjukkan adanya risiko jatuh dan hasil skrining serta intervensi di dokumentasikan.

Semoga dengan adanya Panduan Upaya Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Jatuh, dapat digunakan sebagai panduan atau acuan bagi seluruh staf rumah sakit terutama PPA dalam melakukan skrining dan asesmen risiko jatuh, sehingga tidak ada lagi pasien yang cidera karena jatuh.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 1 Juli 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah